

Introduzione al modulo di Salute Mentale

Salute Mentale · Sessione 01 · 18.02.2026

Questa prima lezione mette sul tavolo le fondamenta di tutto il modulo: che cos'è davvero la salute? Cos'è il benessere? E la normalità? Spoiler: nessuna di queste domande ha una risposta semplice — e proprio da qui parte il bello. Si parla anche della tragedia greca come strumento per avvicinarsi alla sofferenza umana. Roba potente, vedrai.

Il modulo: struttura e filosofia

Il modulo di Salute Mentale si articola su **tre tappe fondanti**, ispirate alla scuola fenomenologica:

1. **La clinica** — l'universo dell'incontro con chi soffre. Si esplorano i concetti di salute e malattia, normalità e patologia, l'incontro empatico con l'altro e i meccanismi di difesa.
2. **Il mondo** — le funzioni psichiche e le loro alterazioni (coscienza, percezione, pensiero, affettività...), per poi passare alla dimensione nosografica: sindromi affettive, ansiose, nevrosi, disturbi di personalità, psicosi.
3. **Il corpo** — teatro della sofferenza: violenza, aggressività, dimensioni anoressico-bulimiche, sessualità come luogo di disagio, alessitimia.

Queste tre tappe sono attraversate da quattro dimensioni esistenziali: **spazio, tempo, identità e incontro**. La clinica va calata in uno spazio e in un tempo, l'identità va declinata nella relazione, e prima della relazione viene l'incontro — senza il quale la relazione non sussiste.

Il prof sottolinea un punto chiave: l'operatore sociale non è un tecnico di una sola disciplina, ma un **trait d'union** tra le specializzazioni. Per questo serve una conoscenza delle aree psicopatologiche — non per fare diagnosi, ma per comunicare con le altre figure professionali e per accompagnare la persona nella sua interezza.

Salute, benessere, normalità: tre concetti

da non confondere

Uno dei messaggi centrali della lezione: **salute, benessere e normalità sono tre cose diverse** che spesso vengono confuse o sovrapposte. Vediamole una per una.

Salute: più complessa di quanto sembra

Il prof parte da una domanda semplice: "Chi di voi sta bene?" Poi mostra quanto sia difficile rispondere. Due paradigmi diversi: puoi andare a fare gli esami del sangue e la TAC (approccio biomedico, *disease*), oppure puoi rispondere "mi sento bene" senza nessun esame (approccio soggettivo, *illness*). Non sono la stessa cosa.

Introduce il lavoro di **Christopher Boorse (1977)**, che nel suo articolo ha tentato di definire la salute esaminando sette possibili condizioni — dimostrando che **nessuna da sola regge**:

Condizione	Perché non basta
Salute come valore	Non tutto ciò che è desiderabile è salute; ci sono contesti dove non essere in salute può essere preferibile (es. durante guerre)
Malattia come ciò che il medico cura	La medicina ha "colonizzato" ambiti non patologici (gravidanza, adolescenza); molte malattie non vengono trattate
Salute come norma statistica	Fuori dalla media ≠ malattia (l'omosessualità è stata classificata come patologia a lungo)

Condizione	Perché non basta
Malattia come sofferenza	Malattie asintomatiche e dolori normali (ciclo mestruale, coliche neonatali, dentizione)
Malattia come disabilità	Tutti attraversiamo fasi di "non abilità" (un neonato non cammina, ma non è malato)
Salute come adattamento	L'essere umano adatta anche l'ambiente a sé. Pensate alle neurodivergenze: a volte è l'ambiente che va cambiato
Salute come omeostasi	Il funzionamento umano si basa su un continuo perdere e riacquistare equilibrio. L'equilibrio statico è rigidità

L'ultimo punto merita attenzione. Il prof insiste: **l'equilibrio statico non è salute, è rigidità**. La metafora è bellissima: camminare richiede di rompere continuamente l'equilibrio. Per fare un passo devi sbilancarti. La vita è movimento, e il movimento richiede di perdere e ritrovare l'equilibrio. "Le persone troppo equilibrate sono spesso molto rigide, poco disposte a rischiare."

"Non c'è movimento senza perdere l'equilibrio, e siccome la vita è costante movimento, occorre mettersi nell'ottica di capire e accompagnare la perdita e la riconquista dell'equilibrio — non impedirla." — Il professore

La triade anglosassone: disease, illness, sickness

Per ordinare le idee sulla salute, il prof introduce la distinzione in tre dimensioni:

- **Disease** — la malattia in senso biomedico, misurabile (esami, parametri clinici)
- **Illness** — il vissuto soggettivo: come la persona *si sente*
- **Sickness** — la dimensione sociale: come la società riconosce (o stigmatizza) quella condizione

Queste tre dimensioni **possono non coincidere**. Una malattia può essere tale per il medico (disease) ma non vissuta come tale dal soggetto (illness), oppure può essere vista dalla società come un vizio (sickness negativa) anche se è una malattia vera.

Questo è importante per il lavoro sociale: lo sguardo della società su una condizione ha effetti reali sul benessere della persona. Se hai una malattia che viene giudicata come "vizio" o "colpa", la stigmatizzazione peggiora tutto — come mostrava già il racconto di apertura della lezione.

Il benessere: un concetto multidimensionale

Salute e benessere non coincidono. Il prof porta l'esempio di **Tiziano Terzani** e del suo libro *L'ultimo giro di giostra*: un giornalista gravemente malato di cancro che attraverso la malattia ha trovato una pace e una ricchezza interiore che non aveva quando stava "bene". Paradossale? No, profondamente umano.

Il benessere è un concetto **polisemico e multidimensionale**. **Carol Ryff** è una psicologa che ha risposto alla domanda: "Quando diciamo che una persona sta bene, di cosa esattamente stiamo parlando?" La risposta: di sei dimensioni distinte.

Dimensione	Cosa significa in concreto
Autonomia	Capacità di determinarsi senza dipendere dagli altri per le proprie scelte
Controllo ambientale	Capacità di cogliere, sfruttare e valorizzare le risorse e le possibilità disponibili
Relazioni positive	Avere relazioni calde, fiduciose, contraddistinte da affetto e reciprocità
Autoaccettazione	Consapevolezza delle proprie qualità e limiti, senza negare né l'uno né l'altro
Percezione di crescita	Sentire che la propria vita è un processo continuo di sviluppo

Dimensione	Cosa significa in concreto
Scopo nella vita	Avere mete, riuscire a dare senso a ciò che si fa

Questo modello è prezioso per l'operatore sociale perché rende il lavoro sul benessere **concreto**. Invece di un generico "lavoro per il benessere", puoi esplorare *quale* dimensione è più critica e intervenire lì. Il prof fa un esempio: se lavori sull'autonomia di qualcuno (aiutarlo a fare scelte proprie), quello starà meglio — anche senza sapere perché. Il prodotto è quello che conta.

Se in un momento la persona non riesce a lavorare sulle relazioni, si compensa sulle altre dimensioni. È un gioco di variabili, non tutto insieme.

Il prof aggiunge: **vale anche per noi**, non solo per i nostri utenti. Se guardiamo indietro alla nostra vita e vediamo solo disastri, non stiamo bene. Se riusciamo a vedere crescita e senso, anche nelle difficoltà, il benessere aumenta.

La normalità: quale normalità?

Il prof introduce tre tipi di normalità — tutti rilevanti per il lavoro con le persone.

1. Norma statistica

La "normalità" come conformità alla media della popolazione. Sembra neutro, ma non lo è: essere fuori dalla norma statistica può provocare stigma, isolamento, discriminazione. L'omosessualità è stata a lungo classificata come patologia proprio su base statistica — e solo quando la comunità scientifica ha cambiato i criteri ne è uscita.

Il contesto è fondamentale: qualsiasi comportamento, senza contesto, può sembrare "anormale".

2. Norma di valore (ideale)

Uno standard ideale che si pone come riferimento. Se il mio ideale è un certo tipo di corpo, starò male finché non ci corrispondo. Ed è un ideale *irraggiungibile*, quindi la sofferenza è perpetua.

Attenzione: la norma ideale incide anche sugli operatori. Abbiamo ideali su come dovrebbe essere un utente, come dovrebbe comportarsi, cosa dovrebbe raggiungere. Se quella norma ideale diventa il metro di lavoro, rischia di diventare penalizzante per la relazione.

3. Norma personale (individuale)

La normalità *rispetto a come funzionavo prima*. Se mi rompo una gamba, non sono più "normale" rispetto al mio funzionamento precedente. Questa dimensione è importante clinicamente: capire com'era il soggetto prima dell'evento permette di comprendere il cambiamento.

Ma il prof aggiunge un avvertimento cruciale: **la normalità personale non è sempre da riconquistare**. A volte è proprio quella "normalità" precedente che ha causato il problema. Esempio: "Lavoravo 10 ore al giorno, gestivo tutto, poi mi sono ammalato — voglio tornare come prima." Forse no. Se torni come eri prima, tra un mese ci rivediamo peggio.

C'è anche il rischio di **idealizzare il passato**: "Prima stavo bene" — ma siamo sicuri? O è solo che in confronto a oggi sembra il paradiso?

La posizione del soggetto davanti alla malattia

L'ultima parte della lezione introduce un modello pratico a due assi per capire come il soggetto si pone rispetto alla propria condizione.

Asse 1 — Identificazione: - *Non mi identifico* con la malattia: "Io non sono la mia malattia, è qualcosa di estraneo" - *Mi identifico*: "La mia condizione fa parte di me"

Asse 2 — Agentività (termine tecnico dal greco): - *Agentivo* (attivo): affronto la situazione, mi muovo, cerco alleati - *Passivo*: subisco, aspetto che qualcuno intervenga

Incrociando i due assi si ottengono quattro posizioni:

	Non si identifica	Si identifica
Passivo	Delega: "Faccia lei, risolva lei"	Passivo nella propria condizione
Agentivo	Guarigione: combatte per eliminare la condizione	Cura: lavora sul proprio benessere dentro la condizione

Il passaggio chiave: quando il soggetto si identifica con la propria condizione e diventa agentivo, il paradigma passa dalla **guarigione** alla **cura**. Non si tratta più di eliminare la malattia (che a volte non è possibile), ma di aumentare il benessere *dentro* la condizione.

"Non tutto si può guarire. Ma tutto può essere curato." — Il professore

La differenza tra *to cure* (terapia) e *to care* (cura) è fondamentale per il lavoro sociale: la terapia non è sempre possibile, ma la cura — nel senso di prendersi cura del benessere della persona — è sempre praticabile.

Nella realtà le persone si muovono tra i quadranti, soprattutto all'inizio della malattia. L'operatore accompagna questo movimento.

La tragedia greca: passioni e follia

Parallelamente allo studio teorico, il modulo include un lavoro su **cinque tragedie greche**.

Perché la tragedia?

La tragedia greca nasce insieme alla medicina antica (Ippocrate) e mette in scena la sofferenza umana — quella difficile da spiegare e a volte da comprendere. Assistere

alla tragedia faceva emergere emozioni e sentimenti che, attraverso la **catarsi**, potevano uscire e liberare.

La tragedia parla dei **confini dell'umano**: la morte, la malattia, la follia. Il prof distingue gli approcci dei tre grandi tragediografi:

- **Eschilo** — il più arcaico: la follia arriva dagli dèi, è una forza esterna che schiaccia
- **Sofocle** — il tragico non arriva dagli dèi, è la vita stessa che è tragica
- **Euripide** — il più moderno: il tragico nasce dalle relazioni tra le persone

A secoli di distanza, la tragedia "resta fedele a se stessa" — perché tocca qualcosa di profondo nell'umano che non cambia nei secoli.

L'esercizio pedagogico

Gli studenti sono divisi in **5 gruppi**, ciascuno con una tragedia assegnata per estrazione. Il lavoro prevede:

1. **Leggere** la tragedia — esporsi a un linguaggio non familiare della sofferenza, proprio come accade quando si incontra un paziente che parla una "lingua" diversa dalla nostra
2. **Condividere** nel gruppo — cosa ti ha parlato? Quali temi ti hanno colpito?
3. **Sintetizzare** — trovare un messaggio comune, con le inevitabili rinunce individuali (esercizio di équipe reale)
4. **Andare in scena** — non uno "spettacolino", ma portare temi salienti a una platea

Il prof insiste: quello che deve arrivare al pubblico deve essere *vero* — deve essere passato attraverso l'umanità di chi lo porta in scena. Se non c'è quella verità, si sente.

Le tragedie di quest'anno

Le docenti hanno scelto — indipendentemente — tragedie che convergono su un tema comune: la **violenza sulle donne nei conflitti armati**.

- **Agamennone** (Eschilo) — Cassandra, prigioniera di guerra e bottino sessuale

- **Le Troiane** (Euripide) — Ecuba, Cassandra, Andromaca: tre donne schiavizzate dopo la caduta di Troia
- **Andromaca** (Euripide) — la vittima di guerra per eccellenza
- **Le Trachinie** (Sofocle) — donne umiliate e "rese mute" dalla violenza
- **Aiace** (Sofocle) — la fragilità dietro l'eroismo apparente

Il prof collega esplicitamente queste storie ai dati odierni sulla violenza sessuale nei conflitti armati (Congo, Iraq, Rwanda), citando **Nadia Murad**, Premio Nobel per la Pace e sopravvissuta alla schiavitù sessuale dell'ISIS. La tragedia greca non è storia lontana: è cronaca con un linguaggio di 2500 anni fa.

Concetti chiave

Termine	Significato
Disease	Malattia in senso biomedico, misurabile con parametri clinici
Illness	Vissuto soggettivo della malattia, come la persona si sente
Sickness	Dimensione sociale della malattia, riconoscimento/stigma
Benessere	Concetto multidimensionale (Ryff): autonomia, controllo ambientale, relazioni, autoaccettazione, crescita, scopo
Norma statistica	Normalità come conformità alla media della popolazione
Norma di valore	Normalità come conformità a un ideale
Norma personale	Normalità rispetto al proprio funzionamento precedente
Agentività	Atteggiamento attivo del soggetto verso la propria condizione
Catarsi	Purificazione emotiva attraverso la partecipazione alla tragedia
Omeostasi	

Termine	Significato
	Equilibrio biologico — la vita si fonda sulla continua perdita e riconquista dell'equilibrio
To cure	Terapia: eliminare la malattia
To care	Cura: prendersi cura del benessere, sempre praticabile

Collegamenti

- **Autori citati:** Christopher Boorse (1977), Carol Ryff, Tiziano Terzani (*L'ultimo giro di giostra*), Callieri & C. (1999), Nadia Murad
- **Lezioni successive:** Storia della follia (25.02), L'incontro con l'alienità (4.03), Dal modello psicoanalitico alle difese (11.03)
- **Temi aperti:** Come cambiano le categorie diagnostiche nel tempo? Come si costruisce una diagnosi psichiatrica? (L'omosessualità come esempio storico sarà ripreso)
- **Da ricordare:** il vademecum del modulo contiene i contenuti in forma scritta con i riferimenti bibliografici precisi